

Antidepressiver

Kode	Analytt	Under	Innenfor	Over
AMTNORSUM	Amitriptylin + nortriptylin	<u>< 10</u>	<u>10 – 1799</u>	<u>≥ 1800</u>
CITAL	Citalopram	<u>< 10</u>	<u>10 – 699</u>	<u>≥ 700</u>
DOKSUM	Doksepin + desmetyldoksepin	<u>< 20</u>	<u>20 – 1099</u>	<u>≥ 1100</u>
DULO	Duloksetin	<u>< 20</u>	<u>20 – 599</u>	<u>≥ 600</u>
ESCIT	Escitalopram	<u>< 10</u>	<u>10 – 279</u>	<u>≥ 280</u>
FLUOSUM	Fluoksetin + norfluoksetin	<u>< 50</u>	<u>50 – 4999</u>	<u>≥ 5000</u>
FLUV	Fluvoksamin	<u>< 20</u>	<u>20 – 1799</u>	<u>≥ 1800</u>
HBUP	Hydroksybupropion	<u>< 100</u>	<u>100 – 7999</u>	<u>≥ 8000</u>
KLOSUM	Klomipramin + desmetylklomipramin	<u>< 10</u>	<u>10 – 1999</u>	<u>≥ 2000</u>
MIASUM	Mianserin + desmetylmianserin	<u>< 10</u>	<u>10 – 1799</u>	<u>≥ 1800</u>
MTZ	Mirtazapin	<u>< 10</u>	<u>10 – 699</u>	<u>≥ 700</u>
NOR	Nortriptylin	<u>< 10</u>	<u>10 – 1199</u>	<u>≥ 1200</u>
PARO	Paroksetin	<u>< 10</u>	<u>10 – 799</u>	<u>≥ 800</u>
SERT	Sertralin	<u>< 5</u>	<u>5 – 499</u>	<u>≥ 500</u>
TRIM	Trimipramin	<u>< 10</u>	<u>10 – 1599</u>	<u>≥ 1600</u>
VENSUM	Venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin	<u>< 20</u>	<u>20 – 3999</u>	<u>≥ 4000</u>
VOR	Vortioksetin	<u>< 5</u>	<u>5 – 199</u>	<u>≥ 200</u>

Stemningsstabiliserende

Kode	Analytt	Under	Innenfor	Over
LAM	Lamotrigin	<u>< 2</u>	<u>2 - 75</u>	<u>≥ 75</u>

Antipsykotika

Kode	Analytt	Under	Innenfor	Over
AMIS	Amisulprid	<u>< 10</u>	<u>10 – 1799</u>	<u>≥ 1800</u>
ARISUM	Aripiprazol + dehydroaripiprazol	<u>< 10</u>	<u>10 – 2199</u>	<u>≥ 2200</u>
BREK	Breksiprazol	<u><10</u>	<u>10 - 600</u>	<u>≥ 600</u>
FLUP	Flupentiksol	<u>< 0,6</u>	<u>0,6 – 34</u>	<u>≥ 36</u>
HALO	Haloperidol	<u><1</u>	<u>1 – 39</u>	<u>≥ 40</u>
KARSUM	Kariprazin + desmetylkariprazin + didesmetylkariprazin	<u><2</u>	<u>2 - 300</u>	<u>≥ 300</u>
KLORP	Klorprotiksen	<u>< 5</u>	<u>5 – 1199</u>	<u>≥ 1200</u>
KLOZ	Klozapin	<u>< 30</u>	<u>30 – 2999</u>	<u>≥ 3000</u>
KVE	Kvetiapin	<u>< 15</u>	<u>15 – 2599</u>	<u>≥ 2600</u>
LMP	Levomepromazin	<u>< 5</u>	<u>5 – 969</u>	<u>≥ 970</u>
LURA	Lurasidon	<u>< 2</u>	<u>2 – 119</u>	<u>≥ 120</u>
OLAN	Olanzapin	<u>< 10</u>	<u>10 – 399</u>	<u>≥ 400</u>
PALI	Paliperidon (hydroksyrisperidon)	<u>< 10</u>	<u>10 – 239</u>	<u>≥ 240</u>

PERF	Perfenazin	<u>< 0,6</u>	<u>0,6 – 13</u>	<u>≥ 14</u>
RISPSUM	Risperidon + hydroksyrisperidon	<u>< 10</u>	<u>10 – 239</u>	<u>≥ 240</u>
ZIPRA	Ziprasidon	<u>< 10</u>	<u>10 – 599</u>	<u>≥ 600</u>
ZUKLO	Zuklopentiksol	<u>< 1</u>	<u>1 – 79</u>	<u>≥ 79</u>

Kommentarer

Analytt	Målt konsentrasjon: grenser for kommentering nmol/L	Kommentar	Referanseområde	Måleområde	Ringegrense
Sum: Amitriptylin + nortriptylin	<10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på summen av amitriptylin og nortriptylin, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	400 - 900	AMI: 10 - 2000 NOR: 10 - 2000	1800
Sum: Amitriptylin + nortriptylin	10 - 1799	Referanseområdet er basert på summen av amitriptylin og nortriptylin, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for			

		klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Amitriptylin + nortriptylin	≥ 1800	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet er basert på summen av amitriptylin og nortriptylin, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Nortriptylin	<10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for nortriptylin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	200 - 600	10 - 2000	1200
Nortriptylin	10 - 1199	Referanseområdet for nortriptylin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd			

		likevektskonsentrasjo n. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Nortriptylin	≥ 1200	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for nortriptylin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n.			
Hydroksybupropio n (kun aktiv metabolitt)	<100	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirent? Siden bupropion er ustabil i serum analyseres kun den aktive metabolitten hydroksybupropion. Referanseområdet er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent	500 - 4000	100 - 10000	8000

		kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Hydroksybupropion (kun aktiv metabolitt)	100 - 7999	Siden bupropion er ustabil i serum analyseres kun den aktive metabolitten hydroksybupropion. Referanseområdet er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjonen. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Hydroksybupropion (kun aktiv metabolitt)	≥ 8000	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Siden bupropion er ustabil i serum analyseres kun den aktive metabolitten hydroksybupropion. Referanseområdet er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd			

		likevektskonsentrasjo n.			
Citalopram	<10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for citalopram er basert på bruk av 20-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	70 - 350	10 - 2000	700
Citalopram	10 - 699	Referanseområdet for citalopram er basert på bruk av 20-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Citalopram	≥ 700	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan			

		rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for citalopram er basert på bruk av 20-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon.			
Escitalopram	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirent? Referanseområdet for escitalopram er basert på bruk av 10-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	25 - 140	10 - 2000	280
Escitalopram	10 - 279	Referanseområdet for escitalopram er basert på bruk av 10-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i			

		sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Escitalopram	≥ 280	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for escitalopram er basert på bruk av 10-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon.			
Sum: Doksepin + desmetyldoksepin	< 20	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på summen av doksepin og desmetyldoksepin, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi	18 - 550	DOKS: 20 - 2000 DDOKS: 20 - 2000	1000

		Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Doksepin + desmetyldoksepin	20 - 1099	Referanseområdet er basert på summen av doksepin og desmetyldoksepin, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjo n. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Doksepin + desmetyldoksepin	≥ 1100	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet er basert på summen av doksepin og desmetyldoksepin, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjo n.			
Duloksetin	< 20	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for duloksetin er basert på bruk av 60-120 mg daglig, prøvetaking	30 - 300	20 - 600	600

		12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Duloksetin	20 - 599	Referanseområdet for duloksetin er basert på bruk av 60-120 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Duloksetin	≥ 600	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for duloksetin er basert på bruk av 60-120 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter			

		siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Sum: Fluoksetin + norfluoksetin	< 50	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på summen av fluoksetin og norfluoksetin ved bruk av 20-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	400 - 2500	FLU: 50 - 3000 NFLU: 50 - 3000	5000
Sum: Fluoksetin + norfluoksetin	50 - 4999	Referanseområdet er basert på summen av fluoksetin og norfluoksetin ved bruk av 20-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi			

		Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Fluoksetin + norfluoksetin	≥ 5000	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet er basert på summen av fluoksetin og norfluoksetin ved bruk av 20-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Fluvoksamin	< 20	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for fluvoksamin er basert på bruk av 100-300 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	60 - 900	20 - 2000	1800
Fluvoksamin	20 - 1799	Referanseområdet for fluvoksamin er basert			

		på bruk av 100-300 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Fluvoksamin	≥ 1800	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for fluvoksamin er basert på bruk av 100-300 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Sum: Klomipramin + desmetylklomipramin	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på summen av klomipramin og desmetylklomipramin, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må	700 - 1500	KLO: 10 - 2000 DKLO: 20 - 2000	2000

		alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Klomipramin + desmetylklomipramin	10 - 1999	Referanseområdet er basert på summen av klomipramin og desmetylklomipramin , prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Klomipramin + desmetylklomipramin	≥ 2000	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet er basert på summen av klomipramin og desmetylklomipramin , prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			

Sum: Mianserin + desmetylmianserin	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på summen av mianserin og desmetylmianserin ved bruk av 60-120 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	150 - 900	MIA: 10 - 2000 DMIA: 20 - 600	1800
Sum: Mianserin + desmetylmianserin	10 - 1799	Referanseområdet er basert på summen av mianserin og desmetylmianserin ved bruk av 60-120 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			

Sum: Mianserin + desmetylmianserin	≥ 1800	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet er basert på summen av mianserin og desmetylmianserin ved bruk av 60-120 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon.			
Mirtazapin	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for mirtazapin er basert på bruk av 15-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	50 - 350	10 - 2000	700
Mirtazapin	10 - 699	Referanseområdet for mirtazapin er basert på bruk av 15-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter			

		siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Mirtazapin	≥ 700	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for mirtazapin er basert på bruk av 15-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon.			
Paroksetin	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for paroksetin er basert på bruk av 20-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål	40 - 400	10 - 1000	800

		kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Paroksetin	10 - 799	Referanseområdet for paroksetin er basert på bruk av 20-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Paroksetin	≥ 800	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for paroksetin er basert på bruk av 20-60 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Sertralin	< 5	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert?	20 - 250	5 - 1000	500

		Referanseområdet for sertralin er basert på bruk av 50-200 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sertralin	5 - 499	Referanseområdet for sertralin er basert på bruk av 50-200 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sertralin	≥ 500	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for			

		sertralin er basert på bruk av 50-200 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon.			
Trimipramin	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for trimipramin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	100 - 800	10 - 2000	1600
Trimipramin	10 - 1599	Referanseområdet for trimipramin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			

Trimipramin	≥ 1600	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for trimipramin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Sum: Venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin	< 20	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på summen av venlafaksin og O-desmetylvenlafaksin ved bruk av 75-375 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	400 - 2000	VEN: 20 - 3000 ODVEN: 20 - 3000	4000
Sum: Venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin	20 - 3999	Referanseområdet er basert på summen av venlafaksin og O-desmetylvenlafaksin ved bruk av 75-375 mg daglig, prøvetaking 12-24			

		timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin	≥ 4000	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet er basert på summen av venlafaksin og O-desmetylvenlafaksin ved bruk av 75-375 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon.			
Vortiksetin	< 5	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for vortiksetin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål	20 - 100	5 - 500	200

		kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Vortioksetin	5 - 199	Referanseområdet for vortioksetin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Vortioksetin	≥ 200	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for vortioksetin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Amisulprid	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for amisulprid er basert på bruk av 50-1200 mg daglig,	100 - 1500	10 - 2000	1800

		prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Amisulprid	10 - 1799	Referanseområdet for amisulprid er basert på bruk av 50-1200 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Amisulprid	≥ 1800	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for amisulprid er basert på bruk av 50-1200 mg daglig, prøvetaking 12-24			

		timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Sum: Aripiprazol + dehydroaripiprazol	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på summen av aripiprazol + dehydroaripiprazol ved bruk av 10-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	200 - 1300	ARI: 10 - 2000 DARI: 20 - 600	2200
Sum: Aripiprazol + dehydroaripiprazol	10 - 2199	Referanseområdet er basert på summen av aripiprazol + dehydroaripiprazol ved bruk av 10-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon.			

		Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Aripiprazol + dehydroariprazol	≥ 2200	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet er basert på summen av aripiprazol + dehydroaripiprazol ved bruk av 10-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon.			
Brekspiprazol	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for brekspiprazol er basert på bruk av 1-4 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysen er ny og begrenset	50 - 330	10 - 600	600

		dokumentasjon foreligger. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Breksipirazol	10 - 600	Referanseområdet for breksipirazol er basert på bruk av 1-4 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Analysen er ny og begrenset dokumentasjon foreligger. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Breksipirazol	≥ 600	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for breksipirazol er basert på bruk av 1-4			

		mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjo n. Analysen er ny og begrenset dokumentasjon foreligger.			
Flupentiksol	< 0,6	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for flupentiksol er basert på bruk av 1-15 mg flupentiksol daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjo n. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	1 -15	0,6 - 36	35
Flupentiksol	0,6 - 34	Referanseområdet for flupentiksol er basert på bruk av 1-15 mg flupentiksol daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjo n. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste			

		injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Flupentiksol	> 36	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for flupentiksol er basert på bruk av 1-15 mg flupentiksol daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon.			
Haloperidol	< 1	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for haloperidol er basert på bruk av 1-20 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste	2 - 25	1 - 60	40

		injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Haloperidol	1 - 39	Referanseområdet for haloperidol er basert på bruk av 1-20 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Haloperidol	≥ 40	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for haloperidol er basert på bruk av 1-20 mg daglig, prøvetaking			

		12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon.			
Sum: Kariprazin + desmetylkariprazin + didesmetylkariprazin	< 2	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på summen av kariprazin, desmetylkariprazin og didesmetylkariprazin ved bruk av 1,5-6 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysen er ny og begrenset dokumentasjon foreligger. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	20 - 150	KARI: 2 - 120 DKARI: 2 - 120 DDKARI: 10 - 300	300
Sum: Kariprazin + desmetylkariprazin + didesmetylkariprazin	2 - 300	Referanseområdet er basert på summen av kariprazin, desmetylkariprazin og didesmetylkariprazin ved bruk av 1,5-6 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og			

		oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysen er ny og begrenset dokumentasjon foreligger. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Kariprazin + desmetylkariiprazin + didesmetylkariiprazin	≥ 300	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet er basert på summen av kariprazin, desmetylkariiprazin og didesmetylkariiprazin ved bruk av 1,5-6 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysen er ny og begrenset dokumentasjon foreligger.			
Klorprotiksen	< 5	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på prøvetaking 12-24 timer etter	10 - 100	5 - 500 (Obs lavere enn ringegrense)	1200

		siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Referanseområdet omfatter ikke bruk av klorprotiksen som primær antipsykotisk behandling. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Klorprotiksen	5 - 1199	Referanseområdet for klorprotiksen er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Referanseområdet omfatter ikke bruk av klorprotiksen som primær antipsykotisk behandling. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Klorprotiksen	≥ 1200	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved			

		Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for klorprotiksen er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Referanseområdet omfatter ikke bruk av klorprotiksen som primær antipsykotisk behandling.			
Klozapin	< 30	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for klozapin er basert på bruk av 100-900 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	300 - 2500	30 - 6000	3000
Klozapin	30 - 2999	Referanseområdet for klozapin er basert på bruk av 100-900 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Analysesvaret må	B		

		alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Klozapin	≥ 3000	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for klozapin er basert på bruk av 100-900 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Kvetiapin	< 15	Kvetiapinkonsentrasjonen lavere enn referanseområdet eller under påvisningsgrensen er forventet ved bruk av doser < 100 mg. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	50 - 700	15 - 3000	2600
Kvetiapin	15 - 2599	Referanseområdet for kvetiapin er basert på bruk av 50-1000 mg daglig, prøvetaking 12 timer +/- 1 time etter			

		siste dose ved bruk av tabletter og 18-24 timer ved bruk av depottablett og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Kvetiapin	≥ 2600	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for kvetiapin er basert på bruk av 50-1000 mg daglig, prøvetaking 12 timer +/- 1 time etter siste dose ved bruk av tabletter og 18-24 timer ved bruk av depottablett og oppnådd likevektskonsentrasjon.			
Levomepromazin	< 5	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for levomepromazin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd	< 300	5 - 500 (Obs lavere enn ringegrense)	970

		likevektskonsentrasjon. Referanseområdet omfatter ikke bruk av levomepromazin som primær antipsykotisk behandling. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Levomepromazin	5 - 969	Referanseområdet er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Referanseområdet omfatter ikke bruk av levomepromazin som primær antipsykotisk behandling. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Levomepromazin	≥ 970	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			

		Referanseområdet er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n. Referanseområdet omfatter ikke bruk av levomepromazin som primær antipsykotisk behandling.			
Lurasidon	< 2	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for lurasidon er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	5 - 60	2 - 200	120
Lurasidon	2 - 119	Referanseområdet for lurasidon er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi			

		Ullevål (se ous.labfag.no).			
Lurasidon	≥ 120	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for lurasidon er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon.			
Olanzapin	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for olanzapin er basert på bruk av 5-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	30 - 200	10 - 600	400
Olanzapin	10 - 399	Referanseområdet for olanzapin er basert			

		på bruk av 5-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Olanzapin	≥ 400	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for olanzapin er basert på bruk av 5-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon.			
Paliperidon (hydroksyrisperidon)	< 10	Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for paliperidon er basert på prøvetaking 0-2	20 - 120	10 - 600	240

		dager før neste depotinjeksjon og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Paliperidon (hydroksyrisperidon)	10 - 239	Referanseområdet for paliperidon er basert på prøvetaking 0-2 dager før neste depotinjeksjon og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Paliperidon (hydroksyrisperidon)	≥ 240	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for paliperidon er basert på prøvetaking 0-2 dager før neste depotinjeksjon og oppnådd			

		likevektskonsentrasjo n.			
Perfenazin	< 0,6	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for perfenazin er basert på bruk av 4-32 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	1 - 7	0,6 - 36	14
Perfenazin	0,6 - 13	Referanseområdet for perfenazin er basert på bruk av 4-32 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende			

		lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Perfenazin	≥ 14	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for perfenazin er basert på bruk av 4-32 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon.			
Sum: Risperidon + hydroksyrisperidon	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet er basert på summen av risperidon + paliperidon (hydroksyrisperidon) ved bruk av 1-8 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevevtskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med	20 - 120	RIS: 10 - 600 PAL: 10 - 600	240

		klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Risperidon + hydroksyrisperidon	10 - 239	Referanseområdet er basert på summen av risperidon + paliperidon (hydroksyrisperidon) ved bruk av 1-8 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Ved bruk av både risperidon og paliperidon vil begge bidra til påvist paliperidonkonsentrasjon (risperidon omdannes til paliperidon). Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Sum: Risperidon + hydroksyrisperidon	≥ 240	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk			

		farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet er basert på summen av risperidon + paliperidon (hydroksyrisperidon) ved bruk av 1-8 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Ved bruk av både risperidon og paliperidon vil begge bidra til påvist paliperidonkonsentrasjon (risperidon omdannes til paliperidon).			
Ziprasidon	< 10	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for ziprasidon er basert på bruk av 40-240 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirert kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	40 - 300	10 - 600	600

Ziprasidon	10 - 599	Referanseområdet for ziprasidon er basert på bruk av 40-240 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Ziprasidon	≥ 600	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for ziprasidon er basert på bruk av 40-240 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon.			
Zuklopentiksol	< 1	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for zuklopentiksol er basert på bruk av 2-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd	5 - 35	1 - 200	100

		likevektskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Zuklopentiksol	1 - 79	Referanseområdet for zuklopentiksol er basert på bruk av 2-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjon. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Zuklopentiksol	≥ 79	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			

		Referanseområdet for zuklopentiksol er basert på bruk av 2-30 mg daglig, prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n. Ved depot anbefales prøvetaking 0-2 dager før neste injeksjon.			
Lamotrigin	< 2*	Manglende etterlevelse? Er riktig analyse rekvirert? Referanseområdet for lamotrigin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n, og er primært etablert for behandling av epilepsi. Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).	10 - 50*	2 - 75*	75*
Lamotrigin	2 - 75*	Referanseområdet for lamotrigin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektskonsentrasjo n, og er primært etablert for behandling av epilepsi.			

		Analysesvaret må alltid ses i sammenheng med klinikk. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no).			
Lamotrigin	≥ 75*	Potensielt toksisk konsentrasjon. Ved spørsmål kan rekvirent kontakte vakthavende lege ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål (se ous.labfag.no). Referanseområdet for lamotrigin er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose og oppnådd likevektsskonsentrasjon, og er primært etablert for behandling av epilepsi.			